

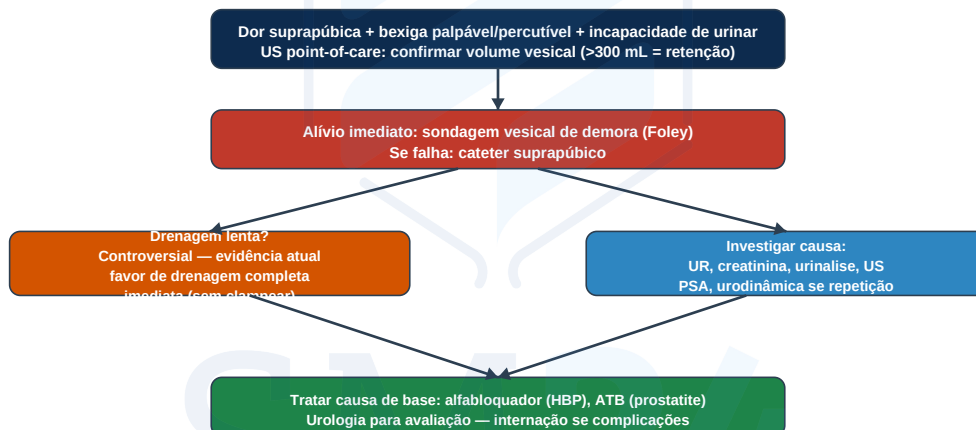
RETENÇÃO URINÁRIA — ALIVIAR + INVESTIGAR

CAUSAS DE RETENÇÃO URINÁRIA AGUDA

Categoria	Causas	Pistas clínicas
Obstrutiva (+ comum no homem)	HBP, câncer de próstata, estenose de uretra, fimose, cálculo uretral	Homem >50 anos, esforço miccional prévio, fluxo fraco
Infecciosa/Inflamatória	Prostatite aguda, uretrite, cistite grave, abscesso periuretral	Febre, dor pélvica, secreção uretral, PSA elevado
Neurogênica	AVC, lesão medular, esclerose múltipla, DM (bexiga neurogênica)	Déficit neurológico, DM de longa data, antecedente de trauma
Farmacológica	Anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos, opioides, anti-histamínicos, alfas	Medicação nova ou recente, idosos polimedicados
Pós-operatória	Anestesia, opioides, imobilidade, edema local	Cirurgia recente (sobretudo pélvica, ortopédica, abdominal)
Funcional (+ comum na mulher)	Cistocele, prolapso de órgão pélvico, pós-parto	Mulher, paridade, dificuldade com força de Valsalva

ABORDAGEM DA RETENÇÃO URINÁRIA AGUDA

RETENÇÃO — ALIVIAR PRIMEIRO, DEPOIS INVESTIGAR



SONDAGEM VESICAL — CATETER DE FOLEY

Etapa	Ação	Detalhes
1	Preparação	EPI (luvas estéreis), campo fenestrado, seringa 10 mL com água destilada, gel lubrificante com lidocaína 2%
2	Antissepsia	Clorexidina 0,5% aquosa: glândula/meato (homem) ou lábios/meato (mulher), de dentro para fora
3	Lubrificação	Instilar lidocaína gel 2% (5-10 mL) na uretra com seringa → aguardar 3-5 min
4	Inserção (homem)	Pênis em 90°; inserir até o Y do cateter; insuflar cuff SOMENTE após fluxo de urina
5	Inserção (mulher)	Identificar meato uretral (anterior à vagina); inserir 5-6 cm; insuflar cuff após urina
6	Fixação	Fitar na coxa/abdome; sistema coletor fechado; monitorar diurese

SONDAGEM DIFÍCIL E ALTERNATIVAS

QUANDO A SONDAGEM URETRAL FALHA

- Estenose uretral: tentar cateter mais fino (12-14 Fr) ou guia hidrofílico
- Próstata muito aumentada: cateter coudé (curvo, bico angulado para cima)
- Falsa via suspeita: parar, não forçar — urologista urgente
- Trauma uretral (fratura de bacia, sangue no meato): NÃO sondar → cistostomia suprapúbica
- Cistostomia suprapúbica: US-guiada, 2 cm acima da sínfise púbica, bexiga cheia (>250 mL)
- Prostatite aguda: sondagem pode ser difícil e dolorosa — sedação local, considerar suprapúbica

COMPLICAÇÕES E CUIDADOS

Complicações Imediatas

- Hematúria ex vacuo: sangramento após drenagem rápida de bexiga muito distendida
- Hipotensão (decompressão brusca): drenagem lenta se >1 L (controverso)
- Falsa via: passagem fora da uretra — dor, resistência, ausência de urina
- Infecção: usar técnica estéril; sistema fechado de drenagem
- Parafimose: fimose não reposicionada após sondagem — reposição imediata

Alta e Seguimento

- Alfabloquador: tansulosina 0,4 mg/d antes da retirada da sonda (melhora TWOC)
- TWOC (Trial Without Catheter): retirar sonda após 1-7 dias, tentativa miccional
- Sucesso do TWOC: ~50-70% com alfabloquador; recorrência indica avaliação urológica
- Encaminhar à urologia: HBP com sintomas, Estenose de uretra, retenção de repetição
- Diário miccional: orientar paciente a registrar frequência e volume urinário

INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU UROLOGIA URGENTE

NÃO DAR ALTA NESSES CASOS

- ☐ Insuficiência renal aguda pós-obstrutiva (creatinina elevada + anúria)
- ☐ Diurese pós-obstrução >200 mL/h (diurese osmótica) — risco de distúrbio hidroeletrólítico
- ☐ Infecção urinária complicada (prostatite, uroseps) — antibiótico IV + internação
- ☐ Retenção com hematúria franca — investigar tumor de bexiga ou de próstata
- ☐ Trauma uretral ou pélvico — urologia urgente, evitar sondagem
- ☐ Retenção em paciente com lesão medular — avaliar nível neurológico + cateterismo intermitente

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Homem de 65 anos com globo vesical e incapacidade de urinar há 8 horas. Qual é a primeira conduta?

- A) Solicitar US renal e urofluxometria antes de qualquer procedimento
- B) Sondagem vesical de alívio (Foley) imediata para aliviar a retenção
- C) Administrar furosemida IV para estimular a diurese
- D) Encaminhar ao urologista sem intervir no PS
- E) Realizar cistoscopia de urgência

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Durante sondagem de Foley em homem, há resistência e o cateter retorna sem urina. Qual a conduta?

- A) Forçar a passagem com maior pressão
- B) Trocar por cateter de maior calibre (22 Fr)
- C) Parar, suspeitar de estenose ou falsa via — tentar cateter coudé ou acionar urologia
- D) Instilar mais gel e tentar novamente por 5 vezes
- E) Realizar cistostomia suprapúbica imediatamente sem outras tentativas

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Em qual situação a sondagem uretral é CONTRAINDICADA e deve-se optar por cistostomia suprapúbica?

- A) Próstata aumentada ao toque retal
- B) Infecção urinária baixa
- C) Sangue no meato uretral + fratura pélvica (suspeita de trauma uretral)
- D) Paciente agitado ou pouco colaborativo
- E) Retenção em mulher grávida

QUESTÃO 4

SES-GO / Adaptada

Qual medicamento deve ser prescrito ao alta para homem com primeiro episódio de retenção urinária por HBP, com cateter de Foley, para melhorar a chance de micção espontânea na retirada da sonda?

- A) Finasterida 5 mg/dia
- B) Tansulosina 0,4 mg/dia (alfabloquador)
- C) Furosemida 40 mg/dia
- D) Ciprofloxacino 500 mg 12/12h
- E) Betanecol colinérgico

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

O momento correto de insuflar o balão do cateter de Foley durante a sondagem masculina é:

- A) Ao atingir 5 cm de inserção (metade da uretra)
- B) Ao sentir resistência na próstata
- C) Somente após observar fluxo livre de urina pelo cateter
- D) Antes de inserir totalmente para fixar a posição
- E) Após confirmar com raio-X a posição vesical

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Retenção urinária aguda: alívio imediato com sondagem vesical (Foley). Exames laboratoriais (UR, Cr) e US são complementares, mas não devem atrasar o alívio. Drenagem imediata alivia dor, previne lesão de bexiga por distensão e avalia complicações (ex: IRA pós-obstrutiva).

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Resistência durante sondagem masculina: parar imediatamente. Suspeitar de estenose uretral (tentar cateter fino 12 Fr) ou falsa via (não forçar — risco de perfuração). Cateter coudé (bico curvo) útil em hiperplasia prostática. Forçar = risco de sangramento, trauma e estenose.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Trauma uretral: sangue no meato + fratura pélvica = CONTRAINDICAÇÃO de sondagem uretral (pode completar ruptura uretral). Conduta: cistostomia suprapúbica de alívio + urologia urgente. Radiografia/uretrografia para avaliar extensão da lesão.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Alfabloquadores (tansulosina, doxazosina) relaxam o músculo liso do colo vesical e prostático → melhora o fluxo urinário. TWOC (Trial Without Catheter) com alfabloquador: taxa de sucesso ~60-70% vs ~40% sem medicação. Iniciar 24-48h antes da retirada da sonda.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Insuflar o balão SOMENTE após urina fluir livremente — confirma que o cateter está no interior da bexiga e não na uretra. Insuflar na uretra causa dor intensa e lesão uretral. No homem, inserir até o Y do cateter antes de insuflar (uretra ~20 cm).

SM24
Suporte ao Plantão Médico